Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora
Volume 2 Nomor 1 September 2024, hlm. 53-64
ISSN: 3024-8965 (Online); ISSN: 3024-9643 (Printed);
Journal Homepage: https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/alamin

Analisis Indeks Pembangunan Manusia pada Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam

Risviyaldi
STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, Indonesia
risviyaldi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze how is the influence of independent variables namely health expenditure, infrastructure expenditure, income per capita, and the level of labor force participation on Human Development Index in 9 member countries of the Organization of Islamic Cooperation, both partially and simultaneously. The analysis method used in this research is panel data regression (pooled data regression analysis), using data from 9 OIC member countries namely: Egypt,Indonesia, Morocco, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Senegal, Ivory Coast, and Ethiopia. The time data used is from 2010 to 2016. The results of this study indicate that: (1) the health expenditure variable has a positive and significant effect with a coefficient of 0.041, (2) infrastructure expenditure has a positive and significant effect with a coefficient of 0.01, (3) and income per capita has a positive and significant effect with a coefficient of 1.06. Whereas the variable labor force participation rate has no influence on Human Development Index. The conclusion of this research is that all the independent variables only one has no effect, namely the labor force participation rate. That was caused by lack of availability of employment in these countries.
Keywords: *Human Development Index, Health, Infrastructure, Income, Labor Force*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh variabel independen yakni belanja kesehatan, belanja infrastruktur, pendapatan per kapita, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 9 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, baik secara parsial maupun simultan. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel (pooled data regression analysis), dengan menggunakan data dari 9 negara anggota OKI yaitu: Mesir, Indonesia, Maroko, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Senegal, Pantai Gading, dan Ethiopia. Data waktu yang digunakan adalah dari tahun 2010 sampai dengan 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) variabel belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,041, (2) belanja infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,01, (3) dan pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 1,06. Sedangkan untuk variabel tingkat partisipasi angkatan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kesimpulan dari peneitian ini adalah bahwa dari seluruh variabel independen hanya satu yang tidak berpengaruh yaitu tingkat partisipasi

angkatan kerja. Hal itu disebabkan oleh kurang tersedianya lapangan kerja pada negara-negara tersebut.
Kata Kunci: *Indeks Pembangunan Manusia, Kesehatan, Infrastruktur, Pendapatan, Angkatan Kerja*

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) mulai menerbitkan secara teratur beberapa indeks dalam Human Development Report tahunannya. Indeks pertama, dan mungkin yang paling populer adalah Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat dengan IPM. IPM Ini menggabungkan tiga komponen atau dimensi dengan bobot yang sama: PDB per kapita, harapan hidup dan ukuran tingkat melek huruf. HDR sejak itu menampilkan konstruksi dan perbaikan dari waktu ke waktu terhadap IPM. Pendekatan pembangunan manusia yang baru berupaya untuk menempatkan manusia kembali sebagai tujuan utama dari pembangunan (UNDP, 1996: 11). IPM pada dasarnya dirancang sebagai cara untuk menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dari pendekatan ini. Ini adalah ringkasan, bukan ukuran komprehensif perkembangan manusia dan pencarian untuk perbaikan metodologis dan data lebih lanjut untuk IPM terus berlanjut (UNDP, 1996: 19).

Menurut laporan dari Bank Dunia disebutkan bahwa kemiskinan masih dirasakan oleh sekitar 10% dari total seluruh penduduk dunia atau 736 juta penduduk dunia masih hidup di bawah 1,90 Dollar AS per hari. Sebagian besar dari jumlah tersebut hidup dalam keadaan miskin yang multidimensi. Kemiskinan multidimensi adalah keadaan dimana seseorang berada pada level pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang rendah (UNDP, 2016: 37).

Dari total seluruh 91 negara berpenduduk miskin di dunia, terdapat 34 negara yang mengalami kemiskinan multidimensi adalah negara-negara dalam keanggotaan OKI atau Organisasi Kerjasama Islam.OKI adalah sebuah organisasi perkumpulan internasional yang terdiri dari bangsa-bangsa atau negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Hal tersebut berarti bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama yang harus dihadapi oleh sebagian besar negara-negara anggota OKI. Padahal tujuan utama dari hadirnya ajaran Islam di dunia adalah untuk mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan bagi umat manusia (Umer Chapra, 2008: 2).

Seiring dengan konsep pembangunan manusia maka organisasi dari PBB telah menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia atas negara-negara ke dalam 4 kategori, yaitu: kelompok negara dengan IPM sangat tinggi yang dihitung dari poin 0,80 sampai 1, kelompok negara dengan IPM tinggi yang dihitung dari poin 0,70 sampai

0,79, kelompok negara dengan IPM sedang yang dihitung dari poin 0,60 sampai 0,69, dan yang terakhir adalah kelompok negara dengan IPM rendah yang dihitung dari poin 0 sampai kepada 0,59.

Menurut laporan dari UNDP Tahun 2018 tentang nilai IPM pada 57 negara anggota OKI terdapat 9 negara yang menduduki nilai IPM sangat tinggi, 14 negara dengan tingkat IPM tinggi, 12 negara dengan tingkat IPM sedang, dan 22 negara menduduki tingkat IPM yang rendah. Maka dapat terlihat bahwa dari kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai oleh 57 negara dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tersebut masih jauh dari kata unggul. Hal ini didasarkan atas pencapaian nilai IPM negara OKI yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari negara-negara tersebut masih termasuk rendah dan menengah.

Dari keseluruhan negara anggota OKI tersebut terdapat 17 negara yang telah mencapai Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 100 miliar dolar AS pada tahun 2017. Angka tersebut menunjukkan besarnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk 17 negara tersebut. Berikut data PDB dari negara anggota OKI yang telah mencapai PDB di atas 100 miliar dolar AS :

Tabel 1.
Data PDB 17 negara anggota OKI

No	Negara	PDB 2017 (Dolar AS)	No	Negara	PDB 2017 (Dolar AS)
1	Indonesia	1.015.539.017.537	10	Mesir	235.369.129.338
2	Turki	851.549.299.635	11	Iraq	192.060.810.811
3	Arab Saudi	686.738.400.000	12	Aljazair	167.555.280.113
4	Iran	454.012.768.724	13	Qatar	166.928.571.429
5	Uni Emirate Arab	382.575.085.092	14	Kazakhstan	162.886.867.832
6	Nigeria	375.745.486.521	15	Kuwait	120.126.277.613
7	Malaysia	314.710.259.511	16	Sudan	117.487.857.143
8	Pakistan	304.951.818.494	17	Maroko	109.708.728.849
9	Bangladesh	249.723.862.487			

Sumber: World Bank (data diolah)

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa negara OKI yang lain pada dasarnya disebabkan karena rendahnya komponen-komponen pembentuk IPM yang telah dicapai selama ini, dan hal ini tidak lepas pula dari adanya peran

pemerintah dalam mendukung peningkatan komponen IPM seperti angka harapan hidup (AHH) yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan sehat, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan dan kemampuan daya beli masyarakat (pendapatan per kapita) untuk mengukur dimensi hidup layak.

Untuk pembangunan manusia dalam konteks negara Muslim, masalah yang paling mendasar dan terkait adalah elemen-elemen tata kelola yang terkait dengan cara menerjemahkan program ke dalam tindakan (efisiensi, transparansi, akuntabilitas), dan pendalaman berbagai model yang mendukung partisipasi dan pemberdayaan yang lebih aktif. Salah satu perangkat yang selama ini dapat digunakan oleh pemerintah adalah perangkat kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal bisa mencakup alat untuk mengalokasikan dana atau anggaran pembangunan ke bidang yang terkait dengan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Dengan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh faktor belanja pemerintah bidang kesehatan, belanja bidang infrastruktur, pendapatan per kapita dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia pada beberapa negara anggota OKI yang masih berada pada tingkat IPM sedang dan rendah.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1: diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel belanja pemerintah bidang kesehatan terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia di 9 negara anggota OKI selama dalam masa penelitian.

Hipotesis 2: diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel anggaran infrastruktur terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia di 9 negara anggota OKI selama dalam masa penelitian.

Hipotesis 3: diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel pendapatan nasional per kapita penduduk terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia di 9 negara anggota OKI selama dalam masa penelitian.

Hipotesis 4: diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia di 9 negara anggota OKI selama dalam masa penelitian.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan analisis data panel. Data panel merupakan gabungan antara data time series dan data cross section. Data time series yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, dan untuk data cross section adalah yang terdiri dari 9 negara anggota OKI dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang rendah dan sedang. Negara-negara yang dijadikan sebagai objek penelitian di sini antara lain adalah: Mesir, Indonesia, Maroko, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Senegal, Pantai Gading, dan Ethiopia.Semua negara tersebut merupakan negara anggota OKI yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Dari data-data tersebut maka terkumpul jumlah keseluruhan data sebanyak 63 unit observasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi: indeks pembangunan manusia setiap negara objek penelitian, belanja pemerintah bidang pendidikan, belanja pemerintah bidang kesehatan, pendapatan nasional per kapita dan partisipasi angkatan kerja dari setiap negara. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier data panel. Analisis regresi adalah metode statistik yang kuat dan memungkinkan untuk memeriksa hubungan antara dua atau lebih variabel yang menarik.

Secara ekonometrika, hubungan antara belanja bidang kesehatan, belanja bidang infrastruktur, pendapatan nasional per kapita, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 9 negara OKI dapat dirumuskan ke dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$IPM = \beta 0 + \beta 1\ KESit + \beta 2\ INFit + \beta 3\ PNPit + \beta 4\ PAKit + \varepsilon it$$

Keterangan:

IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
KES	= Belanja pemerintah bidang kesehatan
INF	= Belanja pemerintah bidang infrastruktur
PNP	= Pendapatan nasional per kapita
PAK	= Partisipasi angkatan kerja
β0	= Intersep
β1 – β4	= Koefisien regresi variabel bebas
i	= data cross section 9 negara anggota OKI
t	= data time series 2010-2016
εit	= Error term.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi Kerjasama Islam atau yang disingkat dengan OKI adalah sebuah organisasi perkumpulan negara-negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. OKI merupakan organisasi antar pemerintah terbesar kedua setelah PBB dengan keanggotaan 57 negara yang tersebar di empat benua. Organisasi ini juga adalah suara kolektif dunia Muslim yang berusaha untuk melindungi dan melindungi kepentingan dunia Muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian dan harmoni internasional di antara berbagai penduduk dunia. OKI didirikan atas keputusan KTT bersejarah yang berlangsung di Rabat, Kerajaan Maroko pada tanggal 13 Rajab 1389 Hijriah (25 September 1969) setelah terjadinya tindakan kriminal yaitu pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki (OIC, 2019).

Tujuan didirikannya OKI adalah untuk untuk meningkatkan dan mengkonsolidasikan ikatan persaudaraan dan solidaritas antar negara negara anggota, kemudian juga untuk melindungi kepentingan bersama dan mendukung tujuan yang sah negara-negara anggota dalam mengoordinasikan dan menyatukan upaya-upaya dalam pandangan tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam pada khususnya dan komunitas internasional pada umumnya (OIC, 2019).

Keanggotaan OKI saat ini berjumlah 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika. Pada awalnya sebagai organisasi internasional OKI lebih banyak menekankan pada masalah politik, namun dalam perjalanannya OKI menjelma menjadi sebuah organisasi internasional yang menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara muslim dari seluruh dunia. Dalam menjawab berbagai tantangan yang muncul, negaranegara anggota OKI telah melaksanakan beberapa kali KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi. Hingga saat ini OKI telah mengadakan KTT yang ke-14 sejak dari awal berdiri (OIC, 2019).

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel independennya ada empat yaitu, belanja untuk kesehatan, belanja infrastruktur, pendapatan per kapita, dan partisipasi angkatan kerja. Berikut adalah statistika deskriptif dari seluruh variabel yang digunakan:

Tabel 2.
Hasil Analisis Deskriptif

Keterangan	IPM	KES	INF	PNP	PAK
Mean	0.556032	22.35107	22.37302	5266.667	60.53017
Median	0.538000	22.42187	22.57652	4710.000	58.36200
Maximum	0.694000	24.09457	24.59686	11240.00	85.55900
Minimum	0.412000	20.48751	19.79037	1050.000	51.03400
Std. Dev.	0.089239	1.059911	1.232893	2980.408	10.06211
Observations	63	63	63	63	63

Sumber: data diolah

Pada tabel 2 di atas dapat dilihat hasil dari analisis deskriptif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai varibel dependen adalah sebesar 0,556032 lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai standar deviasinya yaitu 0,089239. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel IPM adalah baik karena nilai rata-rata lebih tinggi dari pada standar deviasi. Adapun nilai tertinggi dari variabel IPM adalah 0,69 dan nilai terendahnya adalah 0,41.

Kemudian untuk yang selanjutnya adalah variabel independen. Adapun variabel independen yang pertama adalah belanja kesehatan (KES). Nilai rata-rata dari variabel belanja kesehatan adalah 22.35107 dan nilai standar deviasinya adalah 1.059911. Dari data tersebut terlihat bahwa nilai rata-rata lebih tinggi dari pada standar deviasi yang menunjukkan bahwa kualitas variabel dari belanja kesehatan adalah baik. Nilai tertinggi dari variabel belanja kesehatan adalah 24.09457 dan untuk nilai terendah dari variabel belanja kesehatan adalah 20.48751.

Kemudian untuk yang selanjutnya adalah variabel independen. Adapun variabel independen yang pertama adalah belanja kesehatan (KES). Nilai rata-rata dari variabel

belanja kesehatan adalah 22.35107 dan nilai standar deviasinya adalah 1.059911. Dari data tersebut terlihat bahwa nilai rata-rata lebih tinggi dari pada standar deviasi yang menunjukkan bahwa kualitas variabel dari belanja kesehatan adalah baik. Nilai tertinggi dari variabel belanja kesehatan adalah 24.09457 dan untuk nilai terendah dari variabel belanja kesehatan adalah 20.48751.

Variabel independen yang kedua adalah belanja infrastruktur (INF). Nilai rata-rata dari belanja infrastruktur adalah 22.37302 dan nilai standar deviasinya adalah 1.232893. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dari belanja infrastruktur lebih tinggi dari nilai standar deviasinya sehingga kualitas dari variabel tersebut adalah baik. Nilai tertinggi dari belanja infrastruktur adalah 24.59686 dan nilai terendahnya adalah 19.79037.

Variabel independen yang ketiga adalah pendapatan per kapita (PNP). Nilai rata-rata dari pendapatan per kapita adalah 5266.667 dan nilai untuk standar deviasinya adalah 2980.408. Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas variabel pendapatan per kapita adalah baik karena nilai rata-ratanya lebih tinggi dari pada nilai standar deviasinya. Nilai tertinggi dari variabel pendapatan per kapita adalah 11.240 dan nilai terendahnya adalah 1.050.

Variabel independen yang keempat adalah partisipasi angkatan kerja (PAK). Dari data terebut nilai rata-rata untuk variabel partisipasi angkatan kerja adalah 60.53017 dan nilai standar deviasinya adalah 10.06211 yang berarti menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih tinggi dari pada nilai standar deviasinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas dari variabel ini adalah baik. Nilai tertinggi dari variabel partisipasi angkatan kerja adalah 85.55 dan nilai terendahnya adalah 51.03.

Kemudian untuk mengestimasi model *fixed effect* hal yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik variabel *dummy* untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Estimasi ini sering disebut dengan teknik *least square dummy variables*. Berikut adalah hasil dari estimasi *fixed effect.*

Tabel 3. Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.636680	0.165196	-3.854084	0.0003
LN_KES	0.041488	0.006926	5.989890	0.0000
LN_INF	0.010536	0.003521	2.992093	0.0043
PNP	1.06E-05	2.45E-06	4.325703	0.0001
PAK	-0.000431	0.001499	-0.287519	0.7749

Sumber: data diolah

Dari hasil estimasi di atas maka persamaan regresi data panel dapat disusun sebagai berikut:

1. Konstanta (α)

   Pada regresi di atas nilai konstanta yang dihasilkan adalah sebesar -0.636680. Hal ini menunjukkan bahwa ketika jumlah dari belanja kesehatan, belanja infrastruktur, pendapatan per kapita, dan partisipasi angkatan kerja adalah sama dengan nol maka nilai indeks pembangunan manusia pada 9 negara anggota OKI adalah -0.636680.

2. Koefisien (β) regresi Belanja Kesehatan

   Koefisien dari belanja kesehatan adalah berjumlah senilai 0,041488 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,0000. Dengan nilai signifikansi di bawah dari 0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa variabel belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan artian bahwa setiap kenaikan dari belanja kesehatan sebesar 1% maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,041488 dikali 0,01 atau sama dengan 0,00041488.

3. Koefisien Regresi Belanja Infrastruktur

   Koefisien dari belanja infrastruktur adalah sebesar 0,010536 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0043. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia karena masih di bawah 0,05. Artinya setiap ada kenaikan belanja infrastruktur sebesar 1 % maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,010536 dikali dengan 0,01 atau sama dengan 0,00010536.

4. Koefisien Regresi Pendapatan per Kapita

   Hasil koefisien dari pendapatan per kapita adalah sebesar 1,06 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0001. Dengan nilai sigifikansi di bawah 0,05 tersebut menandakan bahwa variabel pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Artinya bahwa setiap ada kenaikan pendapatan per kapita sebesar 1 Dollar maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 1,06.

5. Koefisien Regresi Partisipasi Angkatan Kerja

   Pada variabel partisipasi angkatan kerja menunjukkan koefisien sebesar -0,000431 dengan nilai signifikansi sebesar 0,7749. Dengan nilai signifikansi tersebut yang berada di atas 0,05 menunjukkan bahwa variabel partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas berpengaruh signifikan secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Dalam rangka untuk mengetahui apakah berpengaruh atau tidak maka dilakukan dengan membandingkan antara f hitung dengan f tabel. Jika hasil dari nilai f hitung adalah lebih besar dari pada nilai f tabel maka variabel-variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

Selain itu untuk mengetahui apakah secara keseluruhan variabel independen berpengaruh atau tidak bisa dilihat dari probabilitas f-statistik. Jika kurang dari 0,05 atau 5% maka berpengaruh signifikan. Hipotesis yang digunakan

untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

H_1 :Belanja kesehatan, belanja infrastruktur, pendapatan per kapita, dan partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 9 negara anggota OKI.

Berikut hasil dari uji simultan atau uji F

Tabel 4. Hasil Uji F

Keterangan	Nilai
Prob (f-statistik)	0,000000

Sumber: data diolah

Dari hasil model fixed effect di atas nilai probabilitas f-statistiknya kurang dari 0,05 yaitu 0,000000 maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Artinya variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t adalah uji yang dilakukan secara satu per satu variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan anggapan bahwa variabel yang lain adalah tetap. Untuk menguji apakah setiap variabel bebas berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel terikat bisa dilihat dari nilai probabilitas t-statistik jika nilainya kurang dari 0,05 atau 5% maka berpengaruh secara signifikan. Hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut:

H_1 : masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada 9 negara anggota OKI.

Berdasarkan hasil dari regresi menggunakan model *fixed effect* pada tabel 4. Di atas maka dapat dijelaskan bahwa:

a. Pengaruh belanja kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia, berdasarkan hasil regresi nilai probabilitas t-statistik belanja kesehatan adalah 0,0000 yang artinya kurang dari 0,05. Maka variabel belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM sehingga H_1 diterima.
b. Pengaruh belanja infrastruktur terhadap IPM, berdasarkan hasil dari regresi nilai probabilitas t-statistik belanja infrastruktur adalah 0,0043 yang artinya di bawah dari 0,05. Maka variabel belanja infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM sehingga H_1 diterima.
c. Pengaruh pendapatan per kapita terhadap IPM, berdasarkan hasil dari regresi nilai probabilitas t-statistik pendapatan per kapita adalah 0,0001 yang artinya di bawah dari 0,05. Maka variabel pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM sehingga H_1 diterima.
d. Pengaruh partisipasi angkatan kerja terhadap IPM, berdasarkan hasil dari regresi nilai probabilitas t-statistik partisipasi angkatan kerja adalah 0,7749 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka variabel partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM sehingga H_1 ditolak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran statistik yang mewakili proporsi varians untuk variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen atau variabel dalam model regresi. *R-squared* menjelaskan sejauh mana varians

dari satu variabel menjelaskan varians dari variabel kedua. Jadi, jika R^2 model adalah 0,50, maka sekitar setengah dari variasi yang diamati dapat dijelaskan oleh input model. Berikut adalah hasil dari koefisien determinasi:

Tabel 5. Hasil R-square dan Adjusted R-square

Keterangan	Nilai
R-square	0,995780
Adjusted R-square	0,994767

Sumber: data diolah

Nilai R^2 dari penelitian ini adalah 0,995780 atau 99,57 %, artinya variabel-variabel independen pada model dapat menjelaskan variabel dependen sebanyak 99,57 % dan yang lainnya dijelaskan oleh variabel di luar model.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat IPM di 9 negara anggota OKI pada tahun 2010-2016 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengeluaran pemerintah berupa belanja di bidang kesehatan memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 9 negara anggota OKI. (2) Pengeluaran pemerintah berupa belanja di bidang infrastruktur memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 9 negara anggota OKI. (3) Pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 9 negara anggota OKI (4) Tingkat partisipasi angkatan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 9 negara anggota OKI.

Dari beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diberikan saran-saran terkait hal untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada 9 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam sebagai berikut: Tingkat IPM pada 9 negara anggota OKI yang menjadi objek penelitian masih tergolong kepada kelompok IPM sedang dan rendah sehingga diperlukan peningkatan upaya dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan non ekonomi yang saling mendukung supaya tingkat IPM pada negara-negara tersebut bisa semakin menjadi baik dan akhirnya bisa juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 2. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa salah satu variabel yaitu partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh, maka pemerintah dari setiap negara anggota OKI tersebut harus berupaya meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja agar bisa mendongkrak nilai IPM yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 3. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menyediakan lapangan kerja yang banyak dan luas, sedikitnya lapangan kerja yang ada menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan penghasilan yang tetap sehingga mempengaruhi daya

belinya dan juga kesejahteraannya. 4. Setiap negara memiliki potensi kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda, maka dari itu pemerintahnya harus mampu mengoptimalkan sumber dayanya tersebut agar tercipta lapangan kerja dan pendapatan masing-masing penduduk bisa maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Aminu, Muhtari. 2014. An Islamic Perspective on Human Development. Birmingham: Islamic Relief Worldwide.

Anto, MB Hendrie. 2009. Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. Yogyakarta: FE UII.

Arsyad, Lincolin. 2006. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN. Baghirzade, Narmina. 2012. The Impact of Foreign Direct Investment on Human Development Index in Commonwealth of Independent States". Eastern Mediterranean University.

Chapra, Umer. 2000. The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation.

Chan, C., Forwood, D., H. Roper, and C. Sayers. 2009. 'Public Infrastructure Financing: An International Perspective', Productivity Commission Staff Working Paper.

ESCAP and AITD (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific and Asian Institute of Transport Development). 2003. Evaluation of infrastructural interventions for rural poverty alleviation. Bangkok: ESCAP.

Feldmann, Maryann P. 2014. The Logic of Economic Development: A Definition and Model for Investment. California: Sage Publications.

GIHUB (Global Infrastructure Hub). 2019. "Forecasting Infrastructure Investment Needs and Gaps" dalam https://outlook.gihub.org/

Gujarati, D. N. 2013. Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat. Haq, Mahboob Ul. 1976. The Poverty Curtain-Choices for the Third World. New York: Columbia University Press.

Iqbal, Munawwar., dan Tariqullah Khan. 2004. Financing Public Expenditure: An Islamic Perspective. Jeddah: IRTI IDB.

Kinnunen, Jani. 2019. Impact of Economic and Political Systems on Human Development Index: a Computational Evaluation. International Conference. Kuhn, T. S. 2012. The structure of scientific revolutions: 50th anniversary. Ian Hacking (intro.) (4th ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Kuncoro, Mudrajad. 2005. Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, Jakarta: Erlangga.

Lestari, Windya Wahyu. 2018. Analysis Indicator of Factors Affecting Human

Development Index. Malang: Geosfera Indonesia.

Mangkoesoebroto, Guritno. 2011, Ekonomi Publik Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE.

Mankiw, N. G. 2003. Teori Makro Ekonomi Terjemahan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mylevaganam, Sivarajah. 2017. The Analysis of Human Development Index (HDI) for Categorizing the Member States of the United Nations (UN). Open Journal of Applied Sciences.

Pahlevi, Merita. 2017. “Impact of Governance and Government Expenditure on Human Development in Indonesia”. Institute of Social Studies Erasmus.

Požega, Željko. 2014. “Analysis of The Development of Human Factors – The Impact of Human Capital on Realized and Expected Level of GDP Per Capita of The EU Countries” Preliminary scientific communtication.

Ranis, G. dan F. Stewart. 2006. Economic Growth and HumanDevelopment in Latin America. Cepal No. 78. The UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).

Razmi, Mohammad Javad. 2012. Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran. Mashhad: Ferdowsi University.

Samulelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 2004. Ilmu Makro Eknomi. Jakarta: PT Media Global Edukasi.

Sardak, Sergii. 2019. The Influence of Global Intellectualization on Human Development. Oles Honchar Dnipro National University.

Schultz, Theodore, W. 1961. Investment on Human Capital. The American Economics Review. Sen, Amartya. 1985. Commodities and Capabilities. Amsterdam: North Holland.

Shah, Smith. 2016. Determinants of Human Development Index: A Cross-Country Empirical Analysis. Munich: MPRA.

Siddiqui, M. Nejatullah. 1996. Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective, Leicester: Islamic Foundation.

Stanton, E, A. 2007. The Human Development Indekx : A History. Political Economy Reaserch Institute. Amherst: University of Massachusetts Amhesrt. Streeten, P.P. 1995. Thinking about Development. Cambridge: Cambridge University Press.

Widarjono, Agus. 2013. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

World Bank. 2019. “Health” dalam https://data.worldbank.org/topic/health